Análisis de suelo disponible para el desarrollo urbano

Normativa vigente, crecimiento físico de las ciudades, cobertura sanitaria y valores de suelo

1. Introducción

Las ciudades del país han experimentado un proceso de expansión horizontal, avanzando a un ritmo promedio anual de un 2%[1]. Este proceso se concentra principalmente en los asentamientos del centro-sur de Chile, donde las condiciones económicas y demográficas han favorecido la extensión del área urbana. No obstante, este crecimiento se organiza a partir de una serie de dinámicas que determinan la disponibilidad efectiva de suelo para el desarrollo urbano. En este contexto, conocer y caracterizar estos elementos resulta fundamental para comprender de manera integrada las restricciones que condicionan el desarrollo urbano.

En este documento se caracteriza el suelo disponible para el crecimiento urbano a partir de los diversos elementos que inciden en su configuración espacial y en su potencial de desarrollo. En el caso de Chile, esta disponibilidad se encuentra condicionada por factores institucionales y normativos que actúan sobre el territorio. En este sentido, los instrumentos de planificación territorial cumplen un rol central, ya que definen las áreas con destino urbano mediante el establecimiento de los usos de suelo y normas urbanísticas.

Por su parte, las empresas sanitarias extienden sus áreas de servicio sobre los territorios que, desde el punto de vista normativo son urbanos, aunque por lo general no lo logran cubrirlos por completo. Es por ello que existe un desacople entre el territorio que posee suelo normado y los territorios operacionales de las empresas sanitarias. A su vez, esta interacción genera impactos en los valores del suelo. La factibilidad de acceso a servicios sanitarios se traduce en viabilidad para el desarrollo urbano.

A partir de lo anterior, este documento examina el suelo planificado que define su disponibilidad y relación con los territorios operacionales de las empresas sanitarias, comparándolo con el crecimiento efectivo de los asentamientos humanos. Posteriormente, se abordan los factores económicos, con énfasis en el análisis de transacciones de suelo, lo que permite evaluar las diferencias de precio entre áreas con y sin factibilidad sanitaria.

Los resultados de estos análisis buscan integrar las distintas dimensiones a una escala regional, lo que posibilita identificar patrones territoriales asociados a la expansión urbana y contribuir a una mejor comprensión de los procesos que determinan la disponibilidad de suelo.

[1] Recurso disponible en el siguiente enlace https://storymaps.arcgis.com/stories/08b10266acef4bc5836d1b35ae456b0e

2. Metodología

El análisis se elaboró a partir de cuatro fuentes de información:

A. Límites urbanos y de extensión urbana vigentes a marzo de 2026: límites urbanos definidos por los instrumentos de planificación territorial (Plan Regulador Comunal PRC, Plan Regulador Intercomunal PRI y Plan Regulador Metropolitano PRM). Para efectos de este análisis, se consideran equivalentes los conceptos de suelo planificado y suelo normado.

B. Área urbana construida, también denominada Continuo de Construcciones Urbanas (CCU)[2]: en sus versiones 2017 y 2024, disponible para capitales regionales y provinciales, y 2022, correspondiente al último levantamiento con cobertura nacional.

C. Territorios operacionales de las empresas sanitarias: información oficial de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) correspondiente al año 2025, la cual es de carácter pública y se encuentra disponible en el sitio web de dicha institución. No considera los territorios operacionales rurales de Agua Potable Rural.

D. Transacciones de predios no agrícolas del Servicio de Impuestos Internos (SII): se consideraron las operaciones compra y ventas realizadas entre 2020 y diciembre de 2025 en predios con una superficie igual o superior a 500 m^2. Asimismo, se incluyeron solo aquellas transacciones con valores inferiores a 80 UF/m^2.

La información fue procesada siguiendo los pasos metodológicos:

A. Crecimiento urbano fuera de los límites normativos: el análisis se realizó mediante un procedimiento de información territorial basado en sistemas de información geográfica (SIG) el que permitió identificar la expansión urbana y compararla con el área urbana[3] normada vigente en las capitales regionales y provinciales del país.

   En primer lugar, se estimó el crecimiento urbano a partir de la comparación entre las capas de éste de los años 2017 y 2024[4]. Para ello, se aplicó un cruce espacial a partir del cual se identificó la diferencia de la superficie neta registrada entre ambos períodos.

   Posteriormente, este resultado fue cruzado con la capa de los límites urbanos vigentes lo que permitió determinar las zonas de crecimiento efectivo dentro o fuera del límite urbano y, con ello, identificar aquellas superficies de expansión que se desarrollan fuera del área planificada.

B. Suelo urbano normado disponible en territorios operacionales: el análisis se realizó mediante un procedimiento en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Permitió cuantificar la superficie de suelo urbano normado localizada dentro de los territorios operacionales de las empresas sanitarias, así como el suelo urbano disponible dentro y fuera de dichas áreas.

   Se realizó un cruce espacial entre los territorios operacionales y los límites urbanos, cuyo resultado fue intersectado con la capa del crecimiento urbano a nivel nacional. Para este estudio,

[2] Recurso disponible en el siguiente enlace https://storymaps.arcgis.com/stories/08b10266acef4bc5836d1b35ae456b0e
[3] De acuerdo con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el área urbana "corresponde a la superficie del territorio comprendida al interior del límite urbano, la cual está destinada al desarrollo armónico de los centros poblados y sus actividades existentes" (OGUC, art.1.12). Este marco normativo forma el sustento para la planificación y gestión del desarrollo urbano del país.
[4] Los años 2017 y 2024 coincidentes con la realización de últimos dos Censos de Población y Vivienda. Esto permite que el Instituto Nacional de Estadísticas le impute población al continuo de construcciones urbanas estimado.

se utilizó la versión del Continuo de Crecimiento Urbano (CCU) 2024 de capitales regionales y provinciales, mientras que la versión del CCU 2022 fue utilizada para el resto de los asentamientos del país. Dado que el CCU representa la superficie urbana efectivamente construida, este procedimiento permitió distinguir y cuantificar las áreas edificadas y no edificadas en relación con los territorios operacionales de las empresas sanitarias al interior de las áreas con normativa vigente.

C. Transacciones de suelo urbano en territorios operacionales: se realizó un procedimiento de análisis territorial en SIG, el que permitió identificar las transacciones dentro y fuera del territorio operacional (TO). Con el fin de identificar predios con un valor apto para el desarrollo de la política habitacional, se consideraron aquellos con una superficie superior a 500 m^2 y con un valor menor a 80 UF/m^2. A partir de ello, se contrastaron los precios de suelo dentro y fuera de los territorios operacionales de las empresas sanitarias.

   El procedimiento se desarrolló a través de un cruce espacial de las transacciones con la superficie de suelo urbano planificado. Con este resultado se cuantificó la cantidad y promedio de las transacciones dentro y fuera de los territorios operacionales.

3. Síntesis de resultados

A continuación, se presentan algunos de los principales hallazgos del análisis:

- En la última década las capitales regionales y provinciales han logrado contener parte de su crecimiento dentro de los límites urbanos, sin embargo, persiste un rango de expansión fuera de la planificación. Entre 2017 y 2024, el crecimiento urbano bruto alcanzó 26.609,9 hectáreas, de las cuales un **39,4% se encuentran fuera del límite establecido** (ver tabla 1).
- A nivel país, solo un **37% del suelo urbano normado se encuentra dentro del territorio operacional** de las empresas sanitarias, configurando una brecha entre planificación urbana y provisión territorial de servicios sanitarios (ver tabla 2).
- Un **65% (487.455 ha) del suelo urbano normado se encuentra disponible**. De esta área, **un 13%** está dentro de los territorios operacionales con potencial de desarrollo, evidenciando que la mayor reserva de suelo urbano carece de cobertura sanitaria (ver tabla 3).
- Los valores promedio de transacciones fuera de los territorios operacionales de las empresas sanitarias es de 1,0 UF/m^2, mientras que dentro de ellos el valor promedio asciende a 3,4 UF/m^2. En regiones como la Metropolitana, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y en las capitales regionales, la brecha de precios del suelo dentro y fuera de territorios operacionales es particularmente elevada. Por ejemplo, en la región Metropolitana el valor promedio del suelo fuera de esta área es de 1,2 UF/m^2, y dentro, cercano a 5,6 UF/m^2.

4. Resultados

Los resultados del análisis sistematizan y permiten comparar las principales superficies asociadas al crecimiento urbano, la distribución del suelo urbano normado y disponible, así como las dinámicas de transacciones de suelo en relación con los territorios operacionales de las empresas sanitarias.

Las tablas que acompañan el análisis proporcionan una base cuantitativa para la lectura estructurada de los resultados, facilitando la identificación de patrones regionales, magnitudes y brechas entre planificación urbana y cobertura territorial de servicios sanitarios.

4.1. Crecimiento urbano y límites normativos a nivel regional

En las capitales regionales y provinciales el suelo urbano planificado suma un total de 422.389 hectáreas, de las cuales un 44,8% está construido (189.258 ha). Entre los años 2017 y 2024 se registró un crecimiento urbano bruto de 26.609,9 hectáreas, lo que equivale a un incremento del 14,3 % en la superficie en las principales ciudades del país durante este periodo.

De este total, 16.137 hectáreas (60,8%) corresponden a crecimiento dentro de los límites urbanos y de extensión urbana definidos por los instrumentos de planificación territorial, mientras que 10.472 hectáreas (39,4%) se localizan fuera de dichos límites. Con ello se evidencia que, si bien el crecimiento urbano se concentra mayoritariamente dentro de las áreas normadas, persiste el crecimiento fuera de ellas. Este fenómeno ocurre de manera más evidente en regiones como Arica, Atacama y Los Ríos, que alcanzan valores sobre el 60% de crecimiento urbano fuera del área planificada.

Sin embargo, no todas las ciudades del país crecen fuera de las áreas normadas, ya que existen instrumentos de planificación territorial con áreas de extensión urbana suficientes para su desarrollo. Un ejemplo de ello es la ciudad de Antofagasta, que en el año 2024 presenta una tasa bruta de 9% de crecimiento urbano dentro del área planificada (329,6 ha), en relación con el año 2017.

Cabe destacar la existencia de dinámicas de crecimiento mixto, caracterizadas por una expansión que combina áreas planificadas y no planificadas. En tal sentido, Punta Arenas presenta un patrón de crecimiento urbano mixto, ya que, mientras en ciertos sectores la ciudad se ha expandido dentro del límite urbano, en otros lo ha hecho más allá de éste. Entre 2017 y 2024, la ciudad registró un incremento de 416,6 hectáreas fuera del límite urbano, lo que representa una tasa bruta de crecimiento del 16 % en comparación entre ambos años.

Tabla 1: Tasa de crecimiento urbano en las capitales regionales y provinciales entre los años 2017-2024

Región	Superficie 2017 (ha)	Superficie 2024 (ha)	Crecimiento urbano bruto (ha)	% Crecimiento bruto	Crecimiento dentro del límite urbano (ha)	% Crecimiento en AU*	Crecimiento fuera del límite urbano (ha)	% Crecimiento fuera de AU*
Arica y Parinacota	2.958,7	3.225,9	267,3	9,0%	64,3	24,1%	202,9	75,9%
Tarapacá	3.531,4	3.898,6	367,2	10,4%	240,5	65,5%	126,7	34,5%
Antofagasta	6.503,9	7.663,2	1.159,3	17,8%	531,5	45,8%	651,8	56,2%
Atacama	3.577,8	4.011,9	434,1	12,1%	156,4	36,0%	277,7	64,0%
Coquimbo	8.237,7	9.450,9	1.213,3	14,7%	1.174,0	96,8%	39,3	3,2%
Valparaíso	23.625,7	25.767,7	2.141,9	9,1%	1.145,8	53,5%	996,2	46,5%
Metropolitana	80.042,0	90.903,6	10.861,6	13,6%	6.963,2	64,1%	3.898,40	35,9%
O'Higgins	7.281,9	8.135,0	853,1	11,7%	487,3	57,1%	365,8	42,9%
Maule	8.645,4	10.654,4	2.009,0	23,2%	1.282,0	63,8%	727	36,2%
Ñuble	4.244,0	5.025,7	781,7	18,4%	513,1	65,6%	268,6	34,4%
Biobío	17.168,6	18.548,1	1.379,5	8,0%	828,9	60,1%	550,5	39,9%
La Araucanía	5.504,7	5.932,8	428,1	7,8%	252,3	58,9%	175,8	41,1%
Los Ríos	3.209,6	3.887,1	677,5	21,1%	190,4	28,1%	487,1	71,9%
Los Lagos	6.585,8	9.354,5	2.768,7	42,0%	1.741,7	62,9%	1.049,90	37,9%
Aysén	1.592,5	1.870,5	278,0	17,5%	183,3	65,9%	94,7	34,1%
Magallanes	3.443,1	4.385,3	942,3	27,4%	382,3	40,6%	559,9	59,4%
Nacional	**186.152,6**	**212.715,2**	**26.562,5**	**14,3%**	**16.137,0**	**60,8%**	**10.472,4**	**39,4%**

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Minvu, 2026.
* La sigla “AU” corresponde a área urbana

4.2. Suelo urbano disponible en territorios operacionales

El análisis de la relación entre el suelo urbano normado y los territorios operacionales de las empresas sanitarias evidencia que, a escala nacional, solo un 36,9% del suelo normado se encuentra dentro del territorio operacional sanitario. Esto implica que el 63% del suelo planificado no cuenta actualmente con cobertura sanitaria, lo que constituye un desafío significativo para la viabilidad del desarrollo urbano-habitacional futuro.

Esta brecha presenta marcadas diferencias regionales. En regiones como la Metropolitana, Tarapacá o Arica y Parinacota se concentra una mayor proporción de suelo urbano dentro del territorio operacional sanitario. En cambio, otras como Atacama, Antofagasta o Ñuble presentan niveles muy bajos de cobertura sanitaria. Los valores detallados por región se presentan en la Tabla 2.

De acuerdo con los resultados, un 8,7 % de la superficie urbana disponible se encuentra dentro del territorio operacional de las empresas sanitarias. En contraste, un 56 % del suelo planificado disponible se ubica fuera de dicho territorio, lo que configura un conjunto de áreas planificadas cuyo desarrollo habitacional futuro requerirá, necesariamente, procesos de ampliación de la cobertura territorial de las empresas sanitarias (ver tabla 3).

Tabla 2: Superficie de área urbana normada (AU) dentro y fuera de territorios operacionales (TO) de empresas sanitarias a nivel regional

Región	Área urbana normada (ha)	AU dentro TO (ha)	AU fuera TO (ha)	% AU dentro TO	% AU fuera TO
Arica y Parinacota	4.831,18	2.840,40	1.992,40	58,8%	41,2%
Tarapacá	9.590,73	5.790,25	3.804,90	60,4%	39,7%
Antofagasta	128.985,91	23.427,03	105.595,26	18,2%	81,9%
Atacama	51.435,80	5.429,53	46.008,31	10,6%	89,4%
Coquimbo	48.761,55	12.825,99	35.916,54	26,3%	73,7%
Valparaíso	114.528,30	36.368,11	77.876,76	31,8%	68,0%
Metropolitana	126.583,40	89.101,42	37.504,09	70,4%	29,6%
O'Higgins	42.166,80	14.618,76	27.537,90	34,7%	65,3%
Maule	35.817,00	13.392,06	22.397,92	37,4%	62,5%
Ñuble	38.475,39	7.325,95	31.104,71	19,0%	80,8%
Biobío	73.759,02	29.557,33	44.031,84	40,1%	59,7%
La Araucanía	28.585,74	13.458,13	15.082,61	47,1%	52,8%
Los Ríos	10.057,14	4.878,80	5.156,86	48,5%	51,3%
Los Lagos	24.825,66	12.098,11	12.674,44	48,7%	51,1%
Aysén	5.142,00	2.082,48	3.054,49	40,5%	59,4%
Magallanes	6.128,00	3.665,03	2.464,99	59,8%	40,2%
Nacional	**749.674,00**	**276.859,37**	**472.204**	**37%**	**63%**

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Minvu, 2026, en base a la Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS.

A nivel regional, la mayor cantidad de suelo disponible fuera del territorio operacional sanitario se concentra en Atacama, seguido por Antofagasta. En estas regiones se requieren procesos de ampliación de la cobertura sanitaria. En paralelo, la disponibilidad dentro del territorio operacional, es decir, oportunidad de habilitación más rápida, se ubica principalmente en Tarapacá, Antofagasta y Biobío. Los valores detallados por región se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Suelo no construido normado dentro y fuera de los territorios operacionales

Región	Suelo disponible en LU (ha)	Suelo disponible dentro de TO (ha)	Suelo disponible fuera de TO (ha)	% suelo disponible dentro de TO	% suelo disponible fuera de TO
Arica y Parinacota	2.035,89	349,45	1.686,44	17%	83%
Tarapacá	5.765,64	2.846,64	2.919,00	49%	51%
Antofagasta	119.744,67	16.470,55	103.274,12	14%	86%
Atacama	45.994,73	1.587,01	44.407,72	3%	97%
Coquimbo	34.480,78	2.862,58	31.618,20	8%	92%
Valparaíso	76.525,65	8.323,13	68.202,52	11%	89%
Metropolitana	39.818,72	11.357,46	28.461,26	29%	71%
O'Higgins	27.366,70	3.122,02	24.244,68	11%	89%
Maule	20.740,51	2.053,25	18.687,26	10%	90%
Ñuble	30.362,95	1.521,12	28.841,83	5%	95%
Biobío	47.691,42	7.588,78	40.102,64	16%	84%
La Araucanía	15.190,56	2.725,43	12.465,13	18%	82%
Los Ríos	4.690,81	800,03	3.890,78	17%	83%
Los Lagos	11.727,19	2.444,93	9.282,26	21%	79%
Aysén	3.018,57	457,03	2.561,54	15%	85%
Magallanes	2.301,12	455,03	1.846,09	20%	80%
Nacional	**487.455,89**	**64.964,42**	**422.491,47**	**13%**	**87%**

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Minvu, 2026.

4.3. Los casos de las ciudades de Santiago y Antofagasta

La representación cartográfica de los resultados se ilustra a través de los casos de las ciudades de Santiago y Antofagasta.

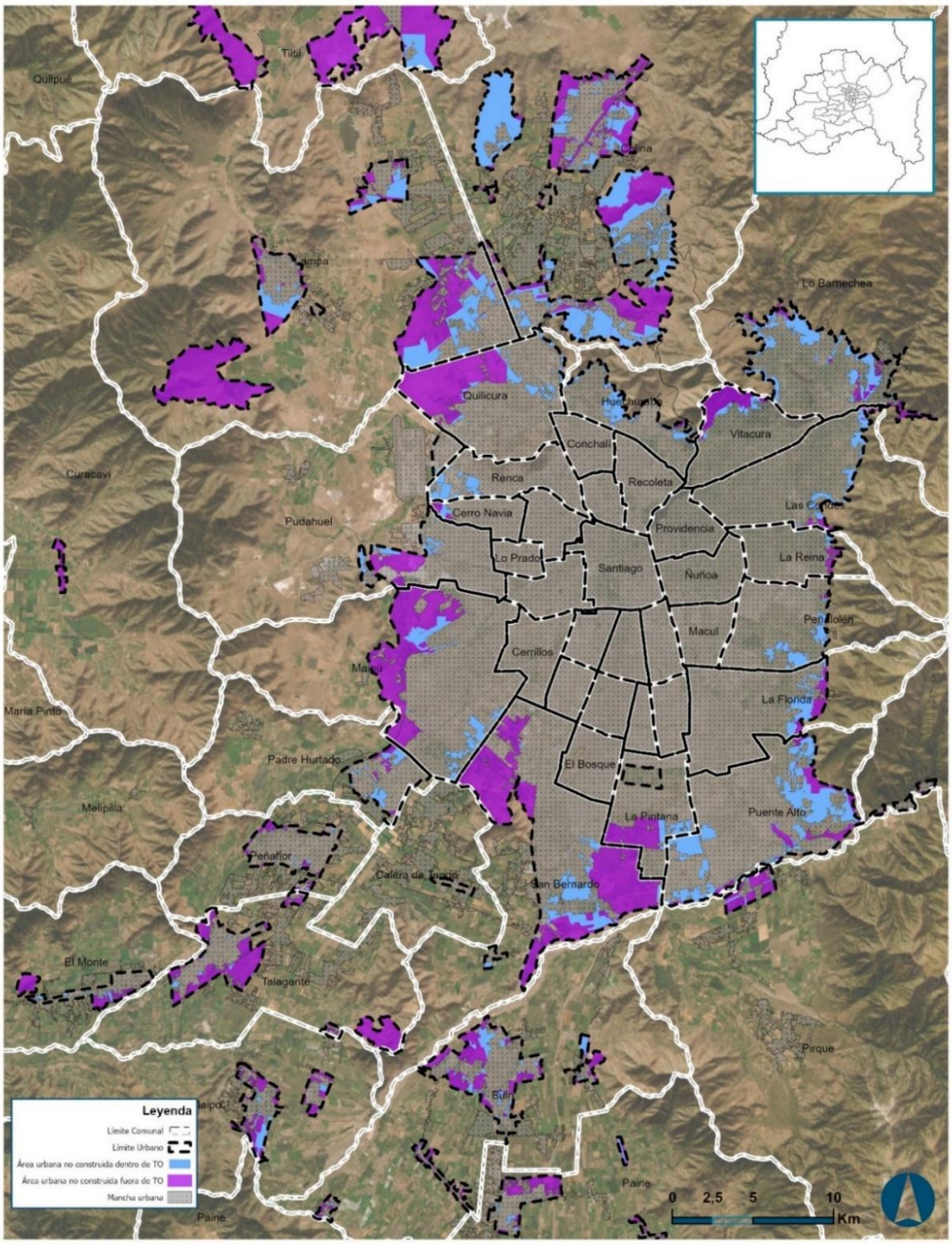
En Santiago, es posible identificar la distribución de las áreas urbanas construidas y disponibles, diferenciando aquellas ubicadas dentro y fuera de los territorios operacionales de las empresas sanitarias. Las áreas urbanas no construidas están concentradas en la periferia metropolitana, especialmente en los sectores norte, poniente y sur. Asimismo, las superficies disponibles localizadas fuera de los territorios operacionales son más extensas y dispersas que aquellas situadas dentro de estos, lo que demuestra importantes reservas de suelo urbano con potencial de absorber procesos de crecimiento, pero que en la actualidad se encuentran limitados debido a la cobertura parcial de las empresas sanitarias (ver figura 1).

Por su parte, Antofagasta presenta una configuración territorial distinta. En este caso, la disponibilidad de suelo urbano para futuros desarrollos es considerablemente mayor que la superficie consolidada en la actualidad, e incluso, las áreas no construidas que cuentan con cobertura sanitaria superan la extensión de la mancha urbana existente. La urbanización se desarrolla de manera lineal a lo largo del litoral, mientras que las áreas urbanas no construidas fuera de los territorios operacionales predominan en amplias extensiones ubicadas al norte y sur de la ciudad. A su vez, estas áreas no

construidas se concentran principalmente en sectores contiguos al tejido urbano consolidado y en zonas de expansión hacia el oriente (ver figura 2).

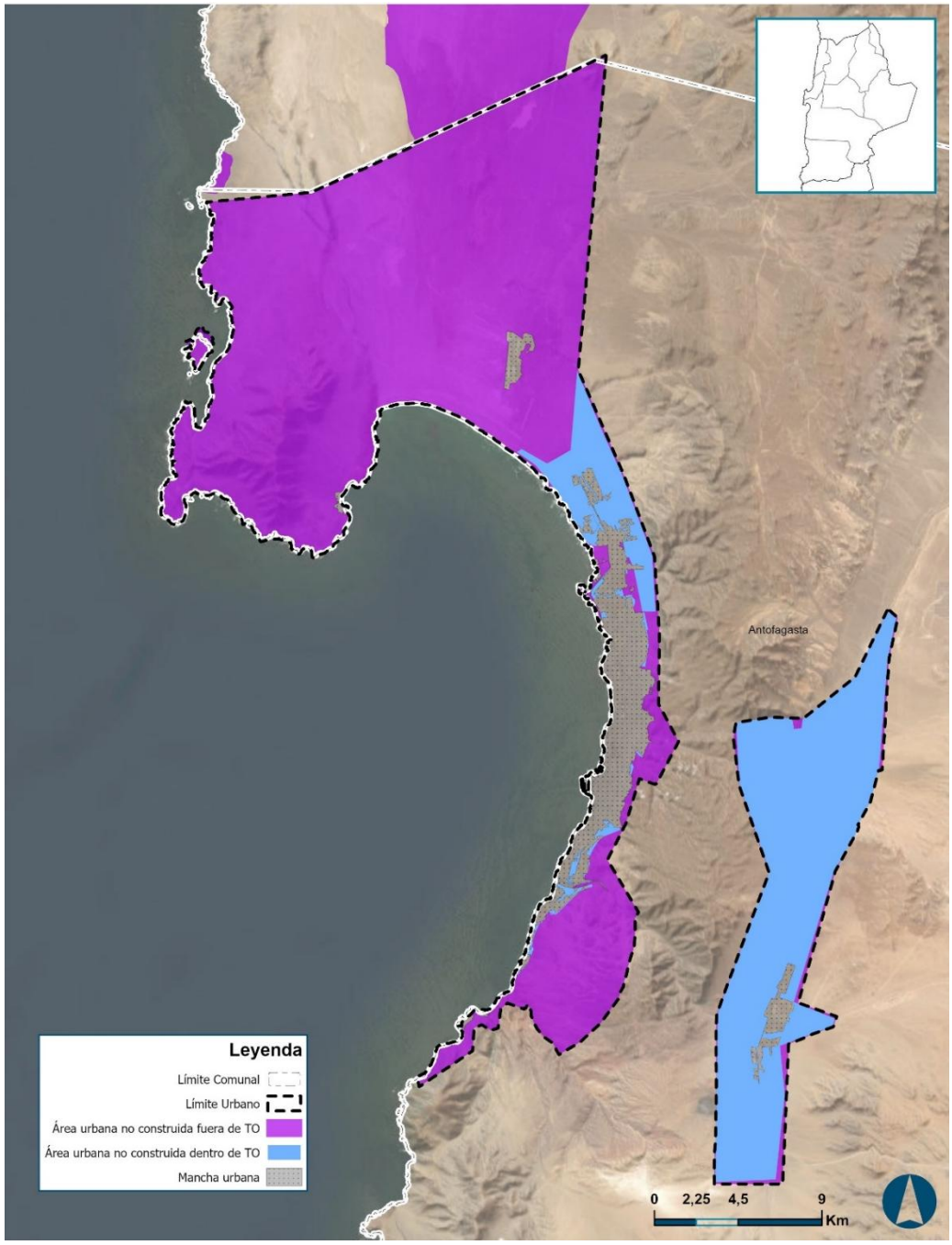
En conjunto, ambos casos reflejan realidades urbanas diferentes: mientras Santiago presenta una expansión periférica asociada a una metrópolis consolidada, Antofagasta dispone de una amplia oferta de suelo urbanizable condicionada por las características geográficas de su territorio.

Figura 1. Superficie de área urbana normada no construida dentro y fuera de los territorios operacionales de las empresas sanitarias, Gran Santiago



Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Minvu, 2026.

Figura 2. Superficie de área urbana normada no construida dentro y fuera de los territorios operacionales de las empresas sanitarias. Antofagasta



Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Minvu, 2026.

4.4. Transacciones y valores promedio: diferencias regionales

La distribución territorial de las transacciones muestra una alta concentración en la zona central del país, especialmente en Valparaíso, la región Metropolitana y Biobío. Este patrón evidencia que la actividad inmobiliaria se concentra en las regiones más pobladas (las tres áreas metropolitanas) y extensas del país.

En cuanto a los precios, existe una marcada concentración de precios mayores en la Región Metropolitana y las del norte grande (Antofagasta, Tarapacá y Arica). En un sentido opuesto, algunas regiones del centro-sur concentran los precios más bajos, destacando en particular los casos de las regiones del Ñuble y Maule. Esta brecha refleja realidades heterogéneas de alta presión de suelos con otras de mayor accesibilidad y potencial de crecimiento (ver tabla 4).

Tabla 4. Magnitud de transacciones de suelo y valor promedio de suelo disponible a nivel nacional

Región	Cantidad transacciones	Valor promedio transacción (uf/m2)
Arica y Parinacota	75	3,6
Tarapacá	222	3,6
Antofagasta	223	3,9
Atacama	455	0,9
Coquimbo	2.108	1,1
Valparaíso	8.147	1,8
Metropolitana	2.936	4,1
O'Higgins	2.481	1,6
Maule	1.809	1,0
Ñuble	2.108	0,5
Biobío	3.026	1,5
La Araucanía	1.161	1,8
Los Ríos	388	1,1
Los Lagos	1.207	1,2
Aysén	126	1,7
Magallanes	257	2,2
Nacional	**26.729**	**1,8**

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Minvu, 2026.

4.5. Valores de suelo según cobertura del territorio operacional

A nivel nacional, la cantidad de transacciones de suelo es considerablemente mayor fuera de los territorios operacionales sanitarios, con 17.778 operaciones frente a 8.951 dentro de éstos (tabla 5). Esta mayor actividad fuera del área de cobertura sanitaria se asocia con valores promedio del suelo más bajos, cercanos a 1,0 UF/m^2, mientras que dentro de los territorios operacionales de las empresas sanitarias el valor promedio asciende a 3,4 UF/m^2. Este patrón se replica en todas las regiones.

A nivel regional existe una combinación heterogénea en cuanto a la relación entre precios de suelo y cantidad de transacciones. En regiones como Valparaíso existe el mayor número de transacciones fuera de territorios operacionales con 6.465 frente a 1.682 dentro, mientras que la Región Metropolitana registra más transacciones al interior de estos territorios (1.963) que fuera (973).

En cuanto a los valores de suelo, los mayores promedios dentro de los territorios operacionales se observan en Tarapacá (7,7 UF/m^2), Arica y Parinacota (5,7 UF/m^2) y en la Región Metropolitana (5,6 UF/m^2). En contraste, fuera de estos territorios los valores son más bajos y homogéneos entre regiones, generalmente por debajo de 2 UF/m^2, lo que refuerza la diferencia sistemática entre estos dos ámbitos territoriales (tabla 5).

Tabla 5. Magnitud de transacciones de suelo y valor promedio de suelo disponible a nivel nacional dentro y fuera de los territorios operacionales (TO)

Región	Fuera de los TO Sanitarias		Dentro de los TO Sanitarias	
	Cantidad transacciones	Valor promedio transacción (uf/m2)	Cantidad transacciones	Valor promedio transacción (uf/m2)
Arica y Parinacota	36	1,4	39	5,7
Tarapacá	134	0,9	88	7,7
Antofagasta	45	2,0	178	4,4
Atacama	349	0,5	106	2,4
Coquimbo	1.620	0,4	488	3,2
Valparaíso	6.465	1,4	1.682	3,5
Metropolitana	973	1,2	1.963	5,6
O'Higgins	1.580	1,4	901	1,8
Maule	1.254	0,6	555	1,8
Ñuble	1.718	0,4	390	1,2
Biobío	1.752	0,6	1.274	2,7
La Araucanía	624	0,9	537	2,9
Los Ríos	278	0,9	110	1,8
Los Lagos	765	0,7	442	2,2
Aysén	73	0,6	53	3,1
Magallanes	112	1,8	145	2,5
Nacional	**17.778**	**1,0**	**8.951**	**3,4**

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Minvu, 2026.

5. Conclusiones

- El crecimiento urbano en las capitales regionales y provinciales se concentra mayoritariamente dentro de los límites definidos por los instrumentos de planificación territorial, sin embargo, existe expansión urbana fuera de las áreas normadas, lo que evidencia desajustes entre la planificación vigente y las dinámicas reales de crecimiento físico de las ciudades. Estas dinámicas, a su vez, condicionan la cobertura de las áreas de servicio de las empresas sanitarias.
- El patrón de crecimiento urbano es diverso, observándose diferencias entre ciudades en función de la configuración de sus instrumentos de planificación.
- Existe una desconexión entre la localización del suelo urbano disponible y la cobertura sanitaria. La mayor proporción del suelo con potencial de desarrollo se encuentra fuera de los territorios operacionales de las empresas sanitarias.
- La infraestructura sanitaria actúa como un factor determinante del desarrollo urbano, influyendo directamente en la localización y el precio del suelo.
- La diferencia de precios entre las transacciones dentro y fuera de los territorios operacionales evidencia el rol de la infraestructura sanitaria. Esto podría ser un factor estructurante del mercado de suelo urbano, lo que, en consecuencia, impacta en los valores de los proyectos habitacionales.
- Se requiere evaluar mecanismos de gestión asociadas a la extensión de los territorios operacionales de las empresas sanitarias.
- Desde una perspectiva de política pública, los resultados refuerzan la necesidad de fortalecer la planificación anticipada de infraestructura sanitaria y de integrar la política de suelo con la inversión pública.

Elaborado por: Anakena Orrego, Alejandro Gutiérrez, Alejandro Lagos. Equipo de Análisis y Gestión de Información Territorial del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio Minvu	Se permite la reproducción total o parcial de este documento, citando la respectiva fuente, siempre y cuando sea con fines académicos o investigativos y no se haga uso comercial.	**Cómo citar este documento**: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (junio de 2026). *Análisis de suelo disponible para el desarrollo urbano: normativa vigente, crecimiento físico de las ciudades, cobertura sanitaria y valores de suelo*. (Documento de trabajo N°10). Centro de Estudios de Ciudad y Territorio. https://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26133